

Douleur postopératoire — adulte & enfant

Évaluer la PEC & morphiniques (1/2)



Champ : prise en charge de la douleur postopératoire (DPO) chez l'adulte et l'enfant — actualisation de la conférence de consensus de 1997. RFE Sfar 2008, comité douleur-ALR et comité des référentiels, 22 experts. **8 thèmes traités, 124 recommandations consensuelles** (4 tours de cotation) : évaluation/amélioration de la PEC (14), utilisation des morphiniques (26), antalgiques non morphiniques (16), agents antihyperalgésiques (9), prévention de la chronicisation (6), infiltration du site opératoire (16), place de l'ALR (30), analgésie en chirurgie ambulatoire (7).

Méthodologie — particularité : cette source n'imprime **aucun tag individuel** (pas de « grade X », pas de « Accord fort/faible ») à côté de chaque recommandation. La méthode GRADE y est utilisée mais la force est encodée **dans le verbe de chaque phrase**, selon la convention que la source définit elle-même : « recommandation forte » = « il est recommandé »/« il faut »/« nous recommandons fortement » (et ses formes négatives « il n'est pas recommandé ») ; « recommandation optionnelle » = « il est probablement recommandé »/« il est possible/probable de » (et formes négatives). **Chip « Fort »/« Faible » attribué ici phrase par phrase selon cette règle explicite de la source** — résolution textuelle disclosée, jamais un tag inventé. La source ne numérote aucune recommandation individuellement : le découpage en lignes ci-dessous est thématique (regroupement de clauses consécutives de même sujet et même force ; jamais deux forces différentes fusionnées sous un chip unique), et son nombre de lignes par thème ne recoupe donc pas nécessairement le chiffre agrégé « 124 » annoncé par la source.

1 — Évaluer et améliorer la prise en charge de la DPO

Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Insister sur l'importance d'une implication institutionnelle avec des objectifs concernant la douleur dans le projet de l'établissement ; inscrire la qualité de la PEC de la DPO dans la réhabilitation postopératoire (récupération fonctionnelle rapide).	Fort
Démarche concertée multidisciplinaire avec définition de référents et responsabilisation des acteurs ; aborder conjointement organisation d'équipes, formation, désignation de personnel référent, information du patient, évaluation de la douleur et procédures de soins.	Fort
Développer des postes d'infirmier référent douleur.	Fort
Informers le patient oralement en pré- puis postopératoire, avec support écrit ; tracer cette information dans le dossier.	Fort
Évaluer l'intensité de la douleur par autoévaluation chiffrée (échelle numérique ou verbale) en préopératoire et en SSPI (critère de sortie de SSPI) ; poursuivre régulièrement en postopératoire (repos, mouvement, après traitement), associée à l'évaluation de la sédation et de la ventilation, et tracée dans le dossier. Évaluer aussi l'incidence de la douleur chronique postchirurgicale (DCPC).	Fort
Développer des protocoles de traitement utilisant les techniques efficaces (ACP morphinique, analgésie multimodale, ALR), intégrant surveillance, prévention et traitement des effets secondaires.	Fort
La prescription à la demande n'est pas recommandée ; prescrire des doses de secours sur des critères fiables (score d'intensité douloureuse).	Fort
Standardisation, préredaction, voire informatisation des prescriptions dans le cadre de procédures thérapeutiques.	Fort
Mesurer la qualité de la PEC de la DPO en évaluant parallèlement structure, procédures et résultats pour le patient, de façon continue et prolongée.	Fort
Pour la structure : recenser le nombre d'infirmières référentes douleur, les moyens financiers/matériels/humains et les formations dispensées ; faire participer l'équipe à toutes les étapes de la démarche qualité.	Fort
Utiliser d'autres méthodes d'évaluation des pratiques professionnelles (chemin clinique, réunions de morbi-mortalité, suivi d'indicateurs — dont ceux de la HAS —, staffs EPP).	Fort
Réaliser des enquêtes « patients » pour évaluer les résultats ; associer l'intensité douloureuse et les effets indésirables (la satisfaction seule est un critère insuffisamment spécifique).	Fort

2 — Utiliser les morphiniques en périopératoire

Morphiniques oraux

Douleur postopératoire — adulte & enfant

Évaluer la PEC & morphiniques (1/2)



Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Réserver les voies sous-cutanée et IV aux patients pour lesquels la voie orale n'est pas disponible ; utiliser la morphine à libération immédiate par voie orale en postopératoire immédiat ou en relais de la voie parentérale (le traitement peut débiter avec la reprise de l'alimentation orale).	Fort
Il n'y a pas de place pour la titration morphinique par voie orale en postopératoire immédiat — la titration IV est préférable.	Fort
Ne pas utiliser le dextropropoxyphène dans l'analgésie postopératoire.	Fort
Utiliser le tramadol, seul ou associé aux antalgiques non morphiniques, en cas de chirurgie à douleur modérée (non contre-indiqué avec la morphine).	Fort

Titration intraveineuse & ACP morphine

Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
La morphine est l'opioïde recommandé pour une titration IV postopératoire immédiate, à partir d'une valeur seuil d'intensité douloureuse (échelle d'auto- ou d'hétéroévaluation, patients non somnolents).	Fort
Bolus de 2 ou 3 mg toutes les 5 minutes.	Faible
Interrompre la titration en cas de somnolence ; surveiller (neurologique, respiratoire, hémodynamique) pendant la titration et jusqu'à 1h après (pic d'action de la morphine, risque de dépression respiratoire).	Fort
Une titration IV postopératoire en morphine n'est pas recommandée dans les unités d'hospitalisation chirurgicale conventionnelle.	Fort
En cas de chirurgie à douleur modérée ou sévère prédictible nécessitant des morphiniques : utiliser l'ACP (morphine, opiacé de choix — aucun avantage à la remplacer par le tramadol), associée à une analgésie multimodale.	Fort
L'association perfusion continue + mode bolus n'améliore pas l'analgésie et majore le risque de dépression respiratoire (seule indication : substitution d'un traitement morphinique préopératoire).	—
En prévention des NVPO (effet indésirable le plus fréquent) : associer en première intention le dropéridol à la morphine dans la pompe d'ACP.	Fort
Le dispositif analgésique transdermique iontophorétique a une efficacité comparable à l'ACP morphine (chirurgie à douleur modérée/sévère prédictible) ; appliquer les mêmes modalités de surveillance.	Fort

Spécificités : sujet âgé et enfant

Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Chez le sujet âgé : titration selon les mêmes modalités que chez le sujet plus jeune, mais dose titrée réduite au-delà de 85 ans, en cas d'altération rénale/hépatique ou de troubles des fonctions supérieures.	Faible
Réduire les doses unitaires de morphine SC et/ou augmenter l'intervalle entre injections chez le sujet âgé, en tenant compte des scores de douleur. L'ACP n'est pas contre-indiquée (programmation identique, mais oxygénothérapie systématique et dose limite horaire).	Fort
Ne pas utiliser le dextropropoxyphène chez le sujet âgé.	Fort
Chez le nouveau-né, le nourrisson et l'enfant, après chirurgie majeure : utiliser la morphine plutôt que les agonistes de palier II (doses réduites chez le nouveau-né et le nourrisson < 3 mois, immaturité hépatique).	Fort
L'ACP est recommandée dès que le niveau de participation est suffisant (en pratique dès 6-7 ans) ; ne pas utiliser la morphine par voie sous-cutanée chez l'enfant (injection douloureuse).	Fort

3 — Antalgiques non morphiniques (ANM)

Analgésie multimodale/balancée : associer plusieurs analgésiques à mécanismes d'action différents pour renforcer l'analgésie et/ou réduire les besoins en morphiniques et leurs effets secondaires.

Douleur postopératoire — adulte & enfant

Morphiniques (2/2) & antalgiques non morphiniques



Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Associer au moins un ANM lorsque la morphine est utilisée en postopératoire par voie systémique.	Fort
Associer un AINS à la morphine en l'absence de contre-indications ; ne pas utiliser les AINS/coxibs en cas d'hypoperfusion rénale ; prendre en compte la majoration du risque hémorragique (AINS non sélectif) et les facteurs de risque athérombotique pour les coxibs (respecter les contre-indications Afssaps).	Fort
Ne pas utiliser seul le paracétamol associé à la morphine dans les chirurgies à douleur modérée à sévère ; ne pas l'administrer par voie IV dès que la voie orale est utilisable.	Fort
Néfopam probablement recommandé après chirurgie à douleur modérée à sévère en association avec les morphiniques — utiliser probablement avec prudence chez le patient coronarien (risque de tachycardie).	Faible
Chez l'enfant : corriger déshydratation/hypovolémie avant AINS ; kétoprofène IV probablement utilisable dès 1 an (hors AMM) ; diclofénac probablement préférable à l'acide niflumique par voie rectale ; pas de recommandation pour les coxibs chez l'enfant (données insuffisantes).	Faible
Ne pas prescrire d'AINS pour l'analgésie postamygdalectomie (risque hémorragique, reprise chirurgicale).	Fort
Chez l'enfant : ne pas administrer le paracétamol par voie IV dès que la voie orale est utilisable, ni par voie rectale (biodisponibilité faible/imprévisible) ; l'administrer de façon systématique et non « à la demande ».	Fort

4 — Agents antihyperalgésiques

L'hyperalgésie postopératoire (périphérique/primaire ou secondaire/centrale) majore la DPO, la consommation d'opioïdes et l'incidence des douleurs chroniques résiduelles.

Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Limiter probablement la consommation d'opioïdes peropératoires pour réduire le risque de tolérance aiguë à la morphine en postopératoire immédiat.	Faible
Kétamine (antagoniste NMDA le plus efficace) : bolus peropératoire 0,15-0,50 mg/kg, relais 0,125-0,25 mg/kg/h si chirurgie > 2h, arrêt de la perfusion 30 min avant la fin de l'anesthésie ; administrer le premier bolus après l'induction (éviter les effets psychodysléptiques).	Fort
Ne pas utiliser l'association morphine-kétamine dans l'ACP postopératoire.	Fort
Ne pas utiliser le magnésium IV (ne limite pas la douleur ni la consommation de morphine) ni la clonidine (effets indésirables hémodynamiques trop marqués) en prévention de l'hyperalgésie.	—
Gabapentine en prémédication probablement recommandée (épargne morphinique, réduction des scores de douleur).	Faible
Lidocaïne IV probablement recommandée pour l'analgésie après chirurgie abdominale en l'absence d'ALR.	Faible

5 — Prévenir la chronicisation de la DPO (DCPC)

DCPC = douleur persistant > 2 mois après chirurgie, sans étiologie identifiée ni continuité avec un problème préopératoire ; incidence difficile à estimer (grande variabilité méthodologique).

Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Prendre en compte la possibilité d'une chronicisation ; rechercher probablement en préopératoire les facteurs de risque (intensité de la douleur préopératoire, type de chirurgie, technique opératoire).	Fort
Une forte DPO (surtout neuropathique) est prédictive d'un risque élevé de DCPC : diagnostiquer et prendre en charge rapidement une douleur neuropathique postopératoire ; utiliser probablement le questionnaire DN4 comme outil de dépistage.	Fort
Chirurgie très ou modérément douloureuse : utiliser de faibles doses de kétamine peropératoire pour prévenir la DCPC.	Fort
Infiltration d'anesthésiques locaux du site chirurgical : limite probablement la DCPC après prise de greffon osseux iliaque.	Faible

Douleur postopératoire — adulte & enfant

Antihyperalgésiques & prévention de la chronicisation



Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Bloc paravertébral probablement recommandé pour réduire la DCPC après chirurgie majeure du sein.	Faible

6 — Infiltration du site opératoire

Administration d'un agent analgésique directement dans les berges d'une cicatrice chirurgicale ou à distance (certains « blocs » comme ilio-inguinal/iliohypogastrique ou plexus cervical superficiel relèvent de cette définition). Respecter les doses maximales d'anesthésiques locaux.

Infiltrations en injection unique

Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Infiltrer la cicatrice de cholécystectomie par laparotomie ; utiliser le bloc des droits pour la cure de hernie ombilicale.	Fort
Cholécystectomie et chirurgie gynécologique par laparoscopie : infiltration des orifices de trocars et instillation intrapéritonéale recommandées. Pour les autres laparotomies abdominales, l'infiltration cicatricielle en injection unique n'a pas d'intérêt significatif en dehors du TAP block.	Fort
Cure de hernie inguinale : infiltration avec un anesthésique local à longue durée d'action (injection en plans profonds ou bloc ilio-inguinal plus efficaces que l'injection SC) ; s'applique aussi aux cicatrices transversales basses (ex. césarienne sous AG).	Fort
Chirurgie hémorroïdaire : infiltration périanale « en quadrants » ou bloc pudendal avec neurostimulation.	Fort
Infiltrer la cicatrice de thyroïdectomie avec des anesthésiques locaux à longue durée d'action.	Fort

Infiltrations continues

Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Perfusion continue cicatricielle sur laparotomies sous-costales et médianes (cathéter en plans profonds/prépéritonéal) ; infiltration continue en plans profonds après hystérectomie par voie abdominale et césarienne.	Fort
Chirurgie majeure du sein et curage axillaire : perfusion continue cicatricielle probablement recommandée (alternative au bloc paravertébral, recommandé en priorité).	Faible
Cure de hernie inguinale : perfusion continue cicatricielle probablement pas utile (malgré une efficacité démontrée).	Faible
Chirurgie cardiaque : infiltration continue cicatricielle (cathéter sur la face antérieure du sternum).	Fort
Chirurgie de l'épaule : infiltration continue subacromiale d'un anesthésique local (en chirurgie ouverte, cathéter possible en sous-cutané, efficacité inférieure à une ALR plexique).	Fort
Prise de greffon iliaque : infiltration continue à proximité de l'os.	Fort
Chirurgie du genou : cathéter intra-articulaire probablement pas recommandé (efficacité limitée, risque pour le cartilage).	Faible

7 — Place de l'ALR dans l'analgésie postopératoire

Règles générales

Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Proposer une technique d'analgésie aux anesthésiques locaux chaque fois que possible ; préférer les blocs périphériques aux blocs centraux dès que possible (meilleur rapport bénéfice/risque).	Fort
Utiliser de préférence la ropivacaïne ou la lévobupivacaïne pour l'analgésie péridurale ou les blocs périphériques (moindre toxicité cardiaque que la bupivacaïne).	Faible

Douleur postopératoire — adulte & enfant

Place de l'ALR (1/2)



Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Respecter les recommandations de pratique clinique de l'ALR pour l'information, la pose et la surveillance des cathéters nerveux/périduraux ; respecter les règles d'asepsie chirurgicale (le repérage échographique est une alternative pour localiser les nerfs périphériques).	Fort
Associer probablement une analgésie multimodale à l'ALR pour compléter l'efficacité et/ou prévenir la douleur à la levée du bloc.	Faible

Blocs du tronc

Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Bloc paravertébral (injection unique ou cathéter) pour diminuer les scores de douleur et l'incidence des NVPO après chirurgie thoracique (alternative utile à la péridurale).	Fort
Bloc paravertébral probablement recommandé après chirurgie majeure du sein.	Faible
Le bloc interpleural ne peut être recommandé (bénéfice limité ne contrebalançant pas le risque de résorption systémique des anesthésiques locaux).	—

Blocs nerveux périphériques

Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Cathéter nerveux périphérique recommandé dès lors que la douleur prévisible modérée à sévère dure > 24h ; mode continu + ACP périnerveuse probablement recommandé pour l'administration d'anesthésiques locaux.	Fort
Le risque de syndrome des loges n'est pas une contre-indication au bloc (sous surveillance adaptée) ; ne pas poser de cathéter en cas d'immobilisation plâtrée postopératoire.	Fort
Épaule : bloc interscalénique recommandé ; si contre-indiqué, bloc suprascapulaire et infiltrations intra-articulaires probablement recommandés.	Fort
Bras et coude : blocs supraclaviculaire ou infraclaviculaire probablement recommandés.	Faible
Avant-bras, poignet, main : blocs axillaire ou au canal huméral probablement recommandés.	Faible
Doigts (rééducation active nécessaire) : blocs tronculaires distaux probablement recommandés.	Faible
Membre inférieur : ne pas utiliser l'analgésie péridurale (blocs périphériques aussi efficaces, moins d'effets indésirables).	Fort
Hanche : bloc fémoral probablement recommandé.	Faible
Diaphyse fémorale, chirurgie ou traumatisme (adulte et enfant) : bloc fémoral recommandé.	Fort
Chirurgie invasive du genou (ex. prothèse totale) : cathéter fémoral recommandé ; bloc sciatique en injection unique probablement recommandé en complément.	Fort
Chirurgie ligamentaire du genou : bloc fémoral (cathéter ou injection unique) probablement recommandé.	Faible
Arthroscopie mineure du genou : administration intra-articulaire d'anesthésique local (± adjuvant) ou bloc fémoral en injection unique recommandés.	Fort
Jambe, cheville, pied (adulte et enfant) : bloc sciatique recommandé.	Fort
Chirurgie mineure du pied : bloc de cheville probablement recommandé (cathéter possible au niveau du nerf tibial).	Faible

Analgesie périmédullaire

Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Injection intrathécale de morphine ≤ 0,1 mg chez le sujet ASA I/II : surveillance possible en secteur traditionnel.	—

Douleur postopératoire — adulte & enfant

ALR (2/2), ambulatoire & sources



Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Analgesie péridurale : anesthésiques locaux à faible concentration + morphinique, cathéter inséré au milieu de la zone des dermatomes à bloquer.	Fort
Analgesie périmédullaire recommandée après chirurgie thoracique ou intra-abdominale majeure (gastrique, pancréatique, colique, grêle, œsophage, cystectomie) — améliore l'analgesie, réduit la durée de l'iléus, raccourcit le délai d'extubation.	Fort
Ne pas utiliser probablement l'analgesie péridurale après chirurgie vasculaire périphérique (aucun impact sur l'analgesie, la morbidité respiratoire/cardiovasculaire).	Faible
Enfant : réaliser un bloc pénien pour l'analgesie après circoncision.	Fort

8 — Organiser l'analgesie en chirurgie ambulatoire

Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Force
Les établissements ayant une activité ambulatoire doivent développer une stratégie spécifique d'évaluation/traitement de la DPO à domicile, évaluée régulièrement et de façon pluridisciplinaire.	Fort
Apprécier les éléments prédictifs de la DPO et de la tolérance aux analgésiques prescrits à domicile ; expliquer les modalités de l'analgesie orale dès la consultation préopératoire (chirurgie, anesthésie).	Fort
Remettre les ordonnances d'antalgiques dès la consultation de chirurgie/anesthésie, précisant les horaires de prise systématique et les conditions de recours à un palier supérieur si nécessaire.	Fort
PEC de la DPO à domicile par voie locorégionale : informer le médecin traitant par avance et le prévenir de la sortie du patient.	Fort
Utiliser les infiltrations et blocs périphériques en injection unique pour la chirurgie ambulatoire lorsque l'indication opératoire s'y prête ; la sortie malgré l'absence de levée du bloc est possible si analgesie de secours, attelles, information écrite, assistance à domicile et procédures d'appel sont prévues.	Fort
Cathéters périnerveux à domicile : réserver aux interventions dont la DPO est totalement (ou en grande partie) couverte par le bloc périnerveux ; contact téléphonique quotidien recommandé.	Fort

Sources et traçabilité

Document source : « Prise en charge de la douleur postopératoire chez l'adulte et l'enfant » (Information professionnelle, RFE 2008, actualisation de la conférence de consensus de 1997). Comité douleur-anesthésie locorégionale et comité des référentiels de la Sfar. Coordonnateurs : D. Fletcher, F. Aubrun. 22 experts + 1 infirmière référente douleur. Ann Fr Anesth Reanim 2008;27:1035-1041.

Méthodologie : méthode GRADE, force codée dans le verbe de chaque phrase (« il est recommandé » = Fort, « il est probablement recommandé » = Faible — voir disclosure méthodologique en page 1), 4 tours de cotation, 124 recommandations consensuelles annoncées par la source (8 thèmes).

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité du contenu prescriptif des 8 thèmes (sections 4 à 11 de la source). Les sections 1-3 (introduction, justification du choix RFE/GRADE) sont résumées dans le panneau de méthodologie plutôt que retranscrites in extenso (contenu procédural sur l'élaboration du référentiel, sans recommandation clinique).

Avertissement — document de 2008 : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des recommandations du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet) et n'est ni éditée ni validée par la Sfar. Certaines pratiques (ex. molécules, voies d'administration) peuvent avoir évolué depuis 2008 : en cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé.